Comportements-problèmes : prévenir, comprendre, gérer la crise

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Analyse fonctionnelle, causes somatiques, plan de crise, « si besoin », mesures restrictives, après la crise.
MAS · FAM · EAM · IME · IEM · EHPAD — médecin d'établissement / coordonnateur, psychiatre, IDE

À RETENIR

Chercher d'abord une cause somatique, la douleur en premier, puis la fonction du comportement. Chaque personne concernée a un plan de crise écrit. Pas de psychotrope « si besoin » sans validation IDE ou médicale ; une mesure restrictive est un dernier recours, surveillé, tracé, débriefé.

Sources : Anesm, « Les comportements-problèmes… : prévention et réponses », volets 1-2 (07/2016) et volet 3 (01/2017)

COMPRENDRE : ANALYSE FONCTIONNELLE

- **Définition** : comportement dont l'intensité, la fréquence ou la durée met probablement en danger la sécurité de la personne ou d'autrui, ou limite l'accès aux services ordinaires.
- Recueil **ABC** : antécédent immédiat, comportement décrit de façon observable (fréquence, intensité, durée), conséquences immédiates.
- Hypothèses, puis test en modifiant le contexte du quotidien ; psychologue et équipe associés.
- **Facteurs de risque** : douleur, sommeil, épilepsie, déficit sensoriel, communication, changement d'environnement ou d'intervenant.

Sources : Anesm 2016, volets 1 et 2 · Anesm 2017, volet 3 (définition, d'après Emerson)

CAUSES SOMATIQUES D'ABORD

- **Douleur** : hétéro-évaluation adaptée (**EDAAP**, **GED-DI** ; enfant : **FLACC** ; âgé : Algoplus, Doloplus). Douleur suspectée : protocole antalgique signé et observation du comportement.
- **À rechercher** : bucco-dentaire, otite, constipation, reflux, cycle menstruel, globe, infection (bandelette), peau, crise d'épilepsie.
- **Iatrogénie** : médicament nouveau, modifié ou arrêté ; polymédication ; psychotropes (bilan biologique selon la molécule).
- Changement **brutal** avec signe de gravité : Fiche 0 (IDE sans délai ou 15).

Sources : Anesm 2016, volet 1, § 2.6 · HAS, troubles du comportement perturbateurs (Alzheimer), 05/2009 · Fiche 0 DOTR

PLAN DE CRISE INDIVIDUEL

- ☐ **Signes annonciateurs** propres à la personne
- ☐ Déclencheurs et situations à risque (soins douloureux, changements, intervenants)
- ☐ Ce qui apaise, ce qui aggrave ; espace de calme-retrait et ses conditions
- ☐ **Rôles** : qui intervient, qui protège les autres, qui appelle (IDE, astreinte, 15)
- ☐ « Si besoin » éventuel : critère écrit, validation IDE ou médecin
- ☐ Souhaits de la personne et de la famille ; techniques de protection apprises en formation
- ☐ Révisé après chaque crise inhabituelle (proposition DOTR)

Sources : Anesm 2016, volet 2 (protocoles individualisés de gestion de crise) · fiche AS « Agitation / crise de comportement »

PSYCHOTROPES « SI BESOIN »

- Prescription : indication en **signes observables**, dose, intervalle minimal, dose maximale par 24 h, surveillance.
- **Validation de l'IDE ou du médecin avant chaque prise** : apprécier l'état clinique n'est pas un acte de la vie courante (TA Dijon, 25/01/2024).
- CAA Lyon (2026) : psychotropes « si besoin » laissés aux veilleurs de nuit sur avis d'un cadre non soignant → EAM placé sous administration provisoire.
- Tracer motif, dose, heure, effet ; prises répétées = réévaluer le traitement de fond.
- Protocole DOTR « Aide à la prise des traitements si besoin ».

Sources : CASF L313-26 · TA Dijon n° 2000998 et CAA Lyon 2026 (via FNASFO, 03/2026) · Anesm 2016, volet 1

MESURES RESTRICTIVES : DERNIER RECOURS

- **Pas de cadre légal propre aux ESMS** : L3222-5-1 CSP ne vise que la psychiatrie (soins sans consentement). Seul un **danger imminent** justifie une mise à l'écart.
- Jamais une **sanction**, jamais sans **surveillance continue** ; durée limitée au danger ; examen somatique immédiat par un soignant. Enfermer pour punir : violences volontaires (Cass. crim., 28/06/2011).
- **Contention** : prescription médicale motivée, réévaluée au moins toutes les **24 h**, surveillance programmée ; pose par l'IDE sur prescription ou protocole.
- EHPAD : mesure durable → annexe au contrat de séjour (L311-4-1).

Sources : Anesm 2017, volet 3, chap. 4 · ANAES, contention physique de la personne âgée (10/2000) · arrêté du 26/06/2026, art. 4 II et art. 2 A

APRÈS LA CRISE

- Blessures recherchées (personne, autres usagers, professionnels).
- **Débriefing** en équipe après toute mesure restrictive ; rapport d'incident ; plan de crise ajusté.
- Temps d'échange avec la personne, une fois apaisée : la crise n'a pas été vécue comme une sanction ; soutien des témoins.
- **Violence** : victime protégée et soignée ; la direction signale (comportements violents d'usagers, maltraitance) ; mineur victime : information préoccupante.
- Situations récurrentes : psychiatre, équipe mobile, instance éthique.

Sources : Anesm 2016, volet 2 · arrêté du 28/12/2016, art. 1, 8° et 10° · fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.